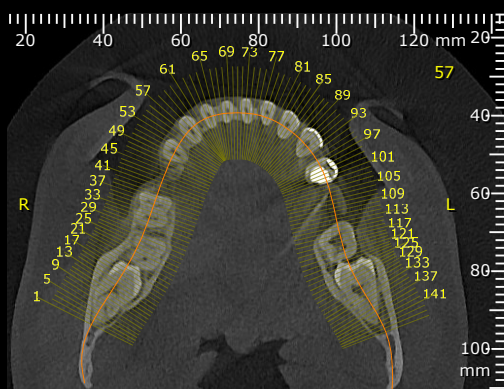
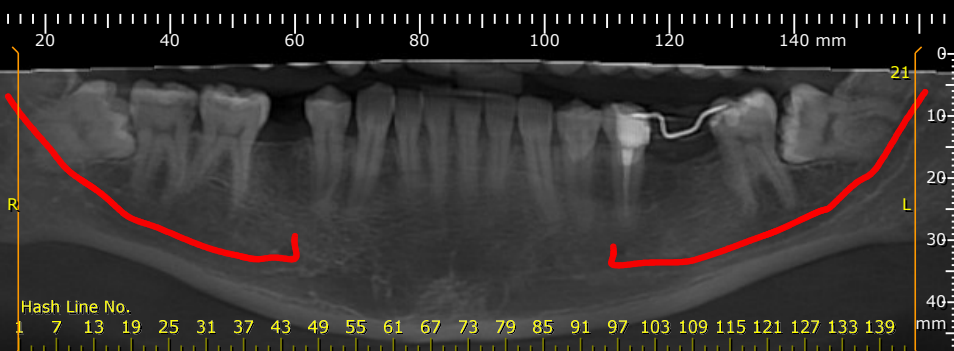


TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

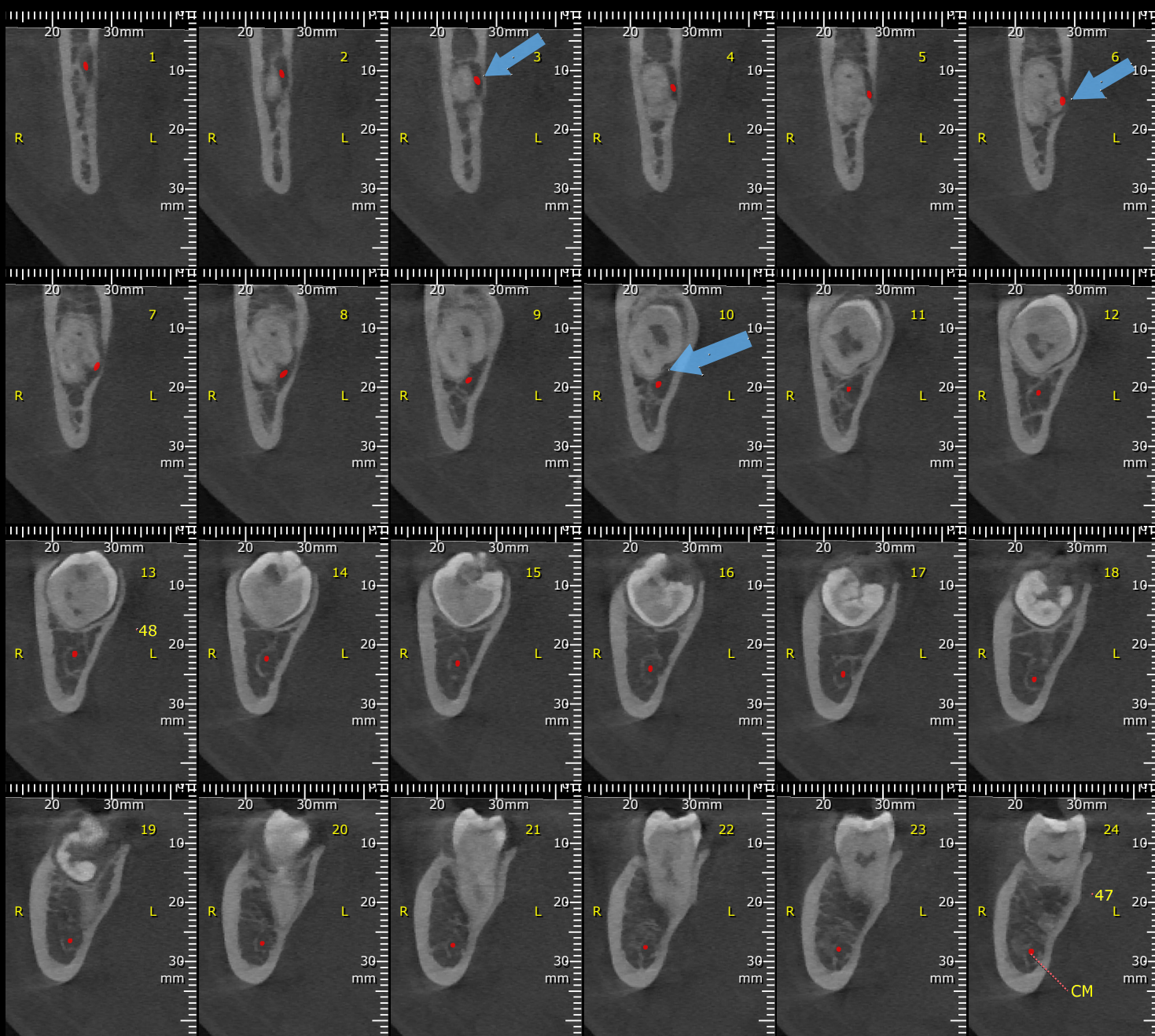
RECONSTRUÇÃO AXIAL



RECONSTRUÇÃO PANORÂMICA



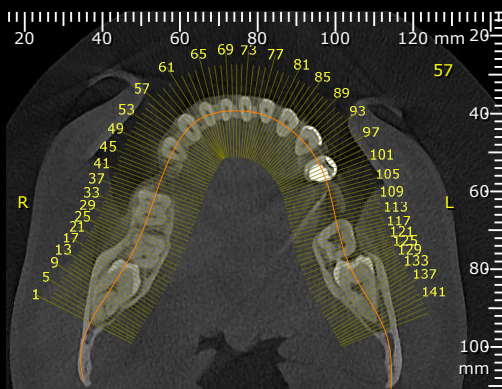
CORTES OBLÍQUOS (1:1), ESPESSAMENTO E ESPAÇAMENTO DE 1MM - TAMANHO REAL



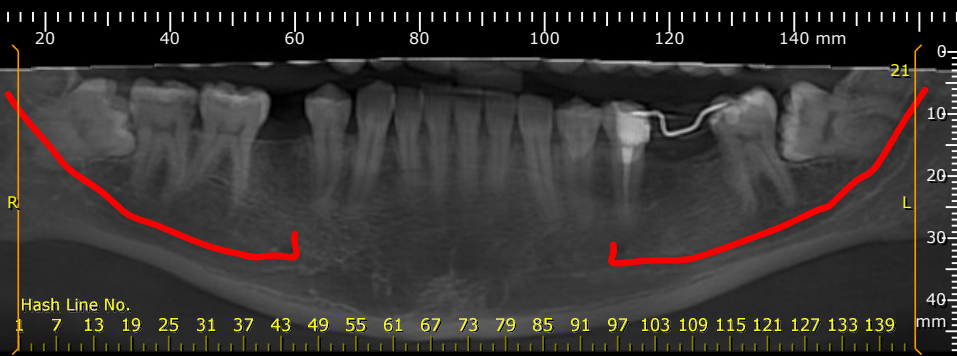
Legendas: SM: Seio Maxilar | CN: Cavidade Nasal | CS: Canalis Sinuosus | CNP: Canal Nasopalatino | CM: Canal da Mandíbula | FM: Forame Mental

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

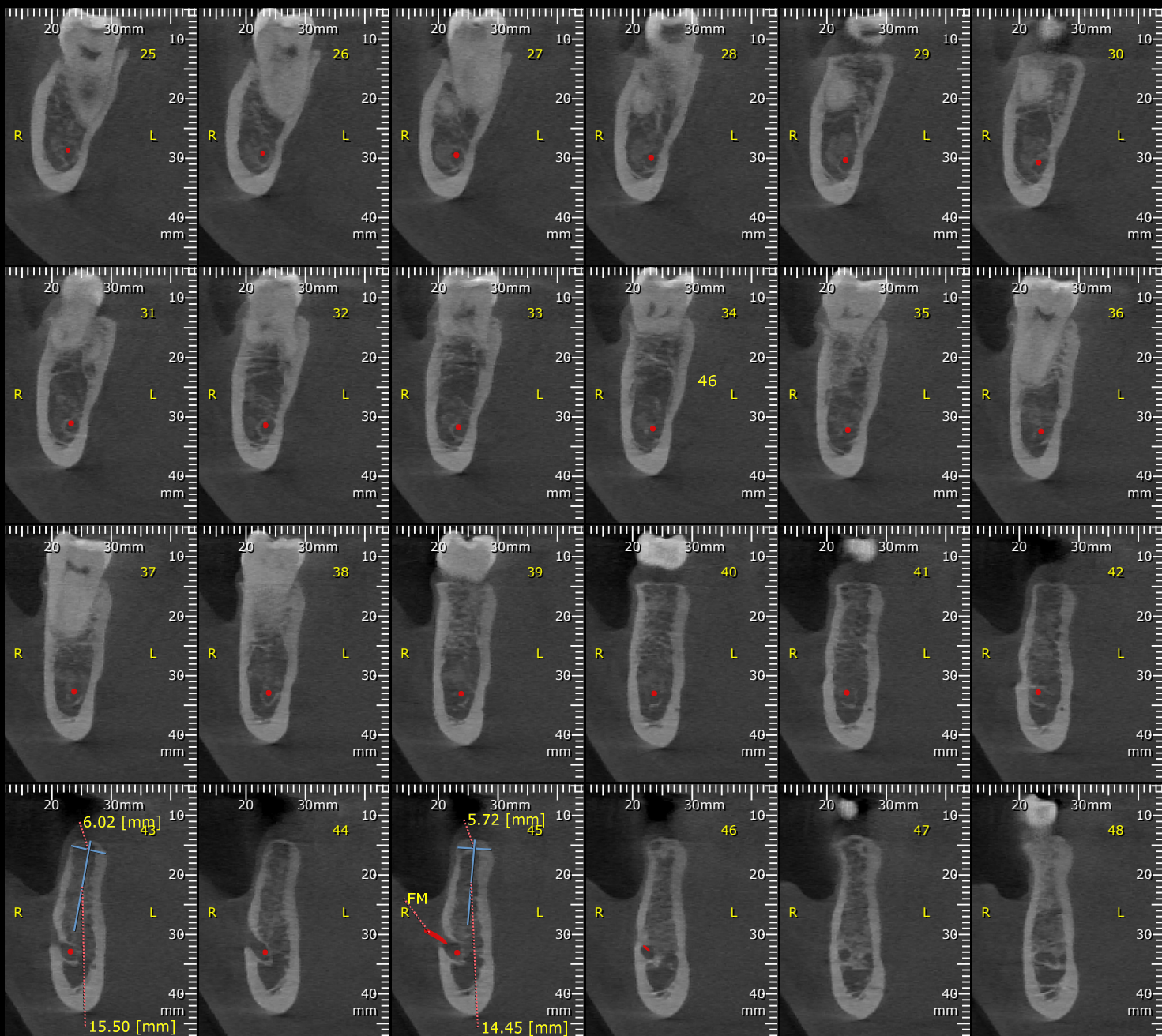
RECONSTRUÇÃO AXIAL



RECONSTRUÇÃO PANORÂMICA



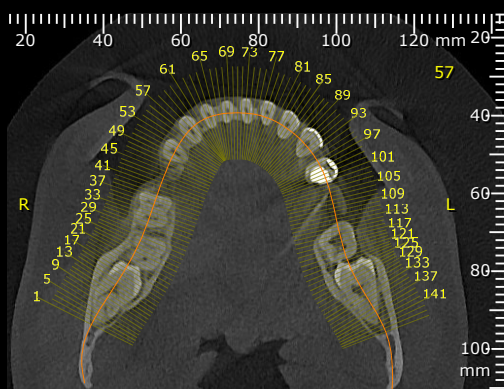
CORTES OBLÍQUOS (1:1), ESPESSAMENTO E ESPAÇAMENTO DE 1MM - TAMANHO REAL



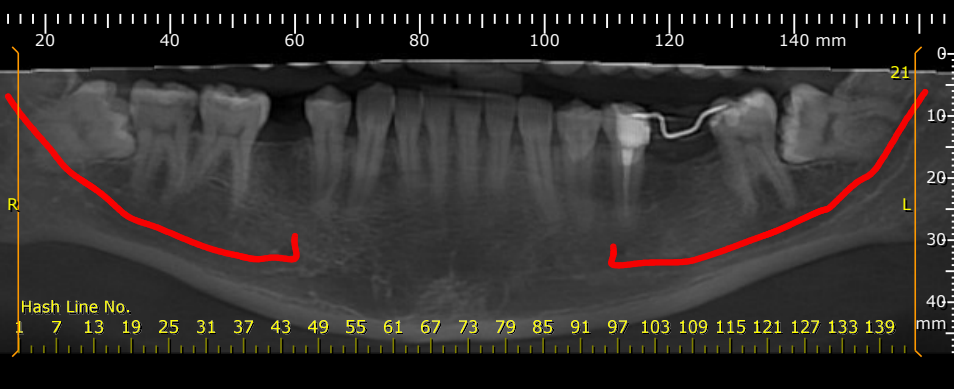
Legendas: SM: Seio Maxilar | CN: Cavidade Nasal | CS: Canalis Sinuosus | CNP: Canal Nasopalatino | CM: Canal da Mandíbula | FM: Forame Mental

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

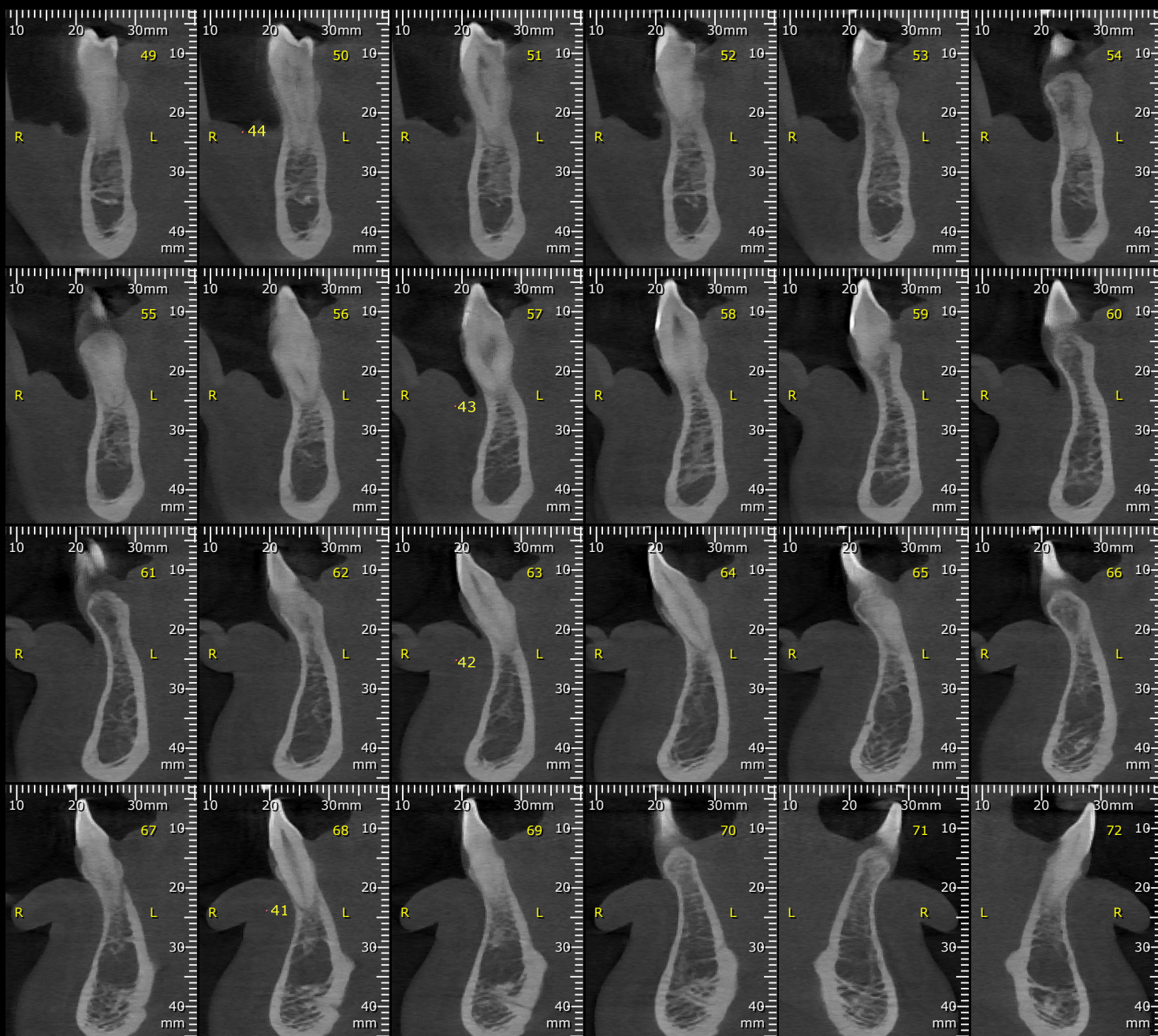
RECONSTRUÇÃO AXIAL



RECONSTRUÇÃO PANORÂMICA



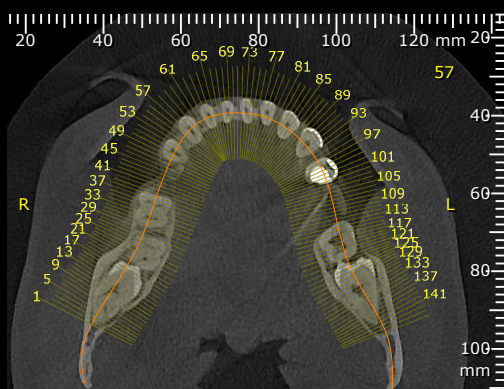
CORTES OBLÍQUOS (1:1), ESPESSAMENTO E ESPAÇAMENTO DE 1MM - TAMANHO REAL



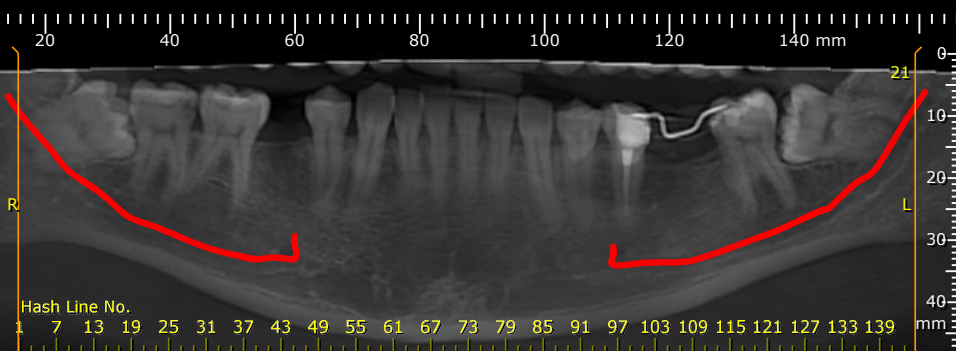
Legendas: SM: Seio Maxilar | CN: Cavidade Nasal | CS: Canalis Sinuosus | CNP: Canal Nasopalatino | CM: Canal da Mandíbula | FM: Forame Mental

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

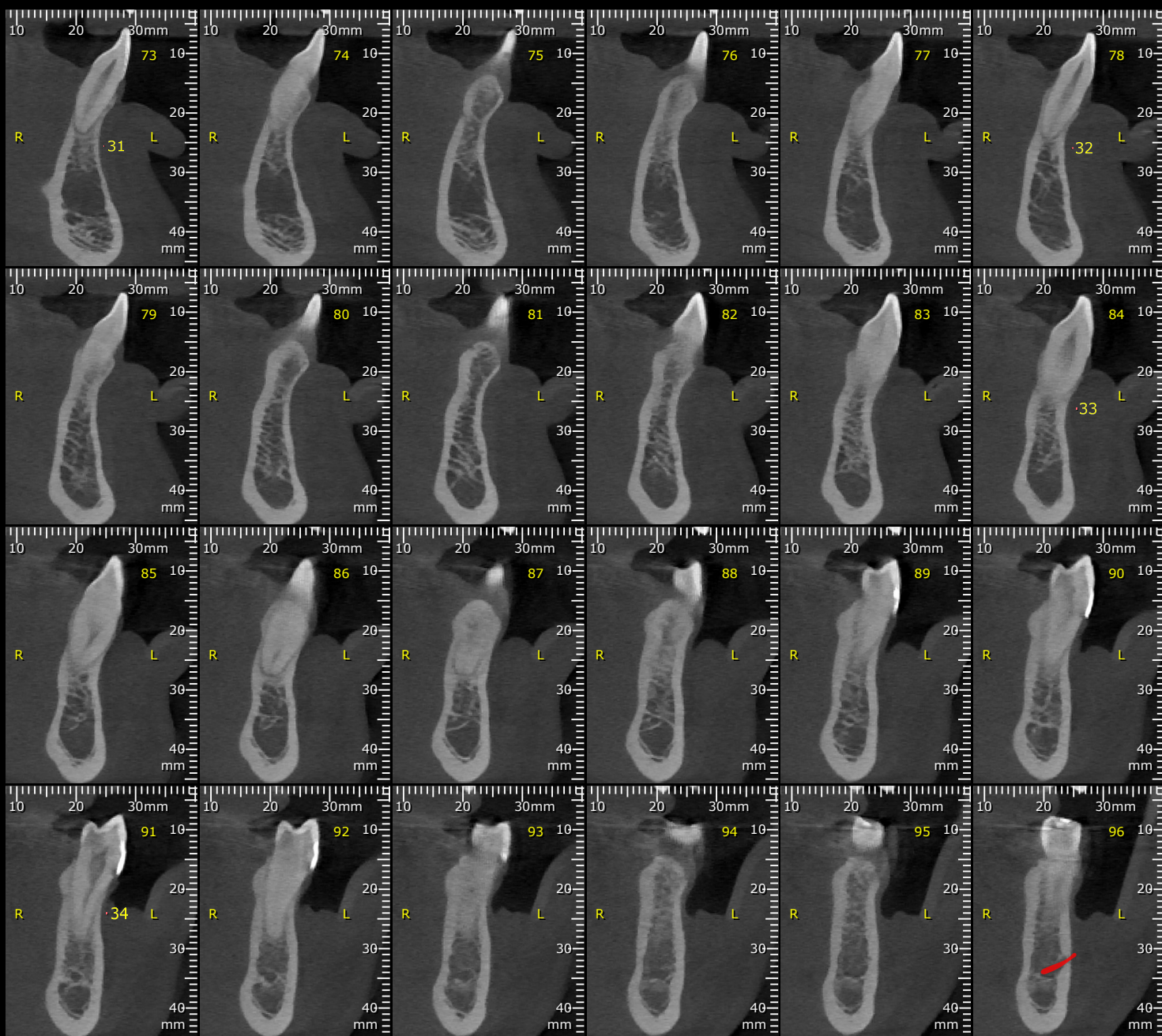
RECONSTRUÇÃO AXIAL



RECONSTRUÇÃO PANORÂMICA



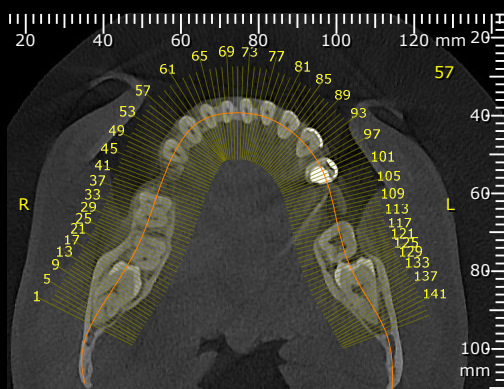
CORTES OBLÍQUOS (1:1), ESPESSAMENTO E ESPAÇAMENTO DE 1MM - TAMANHO REAL



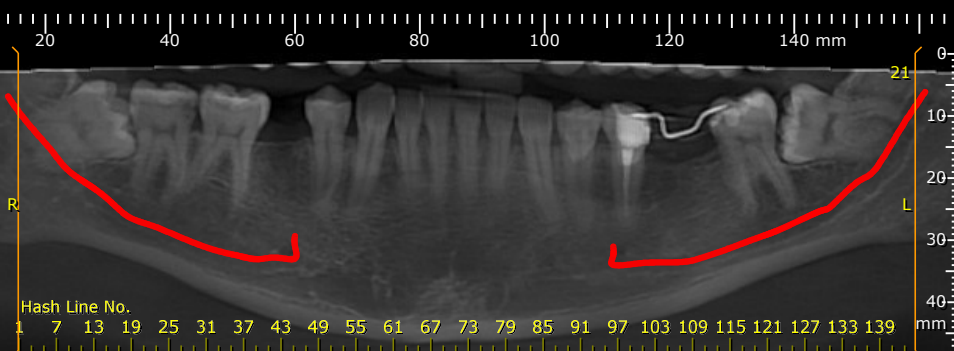
Legendas: SM: Seio Maxilar | CN: Cavidade Nasal | CS: Canalis Sinuosus | CNP: Canal Nasopalatino | CM: Canal da Mandíbula | FM: Forame Mental

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

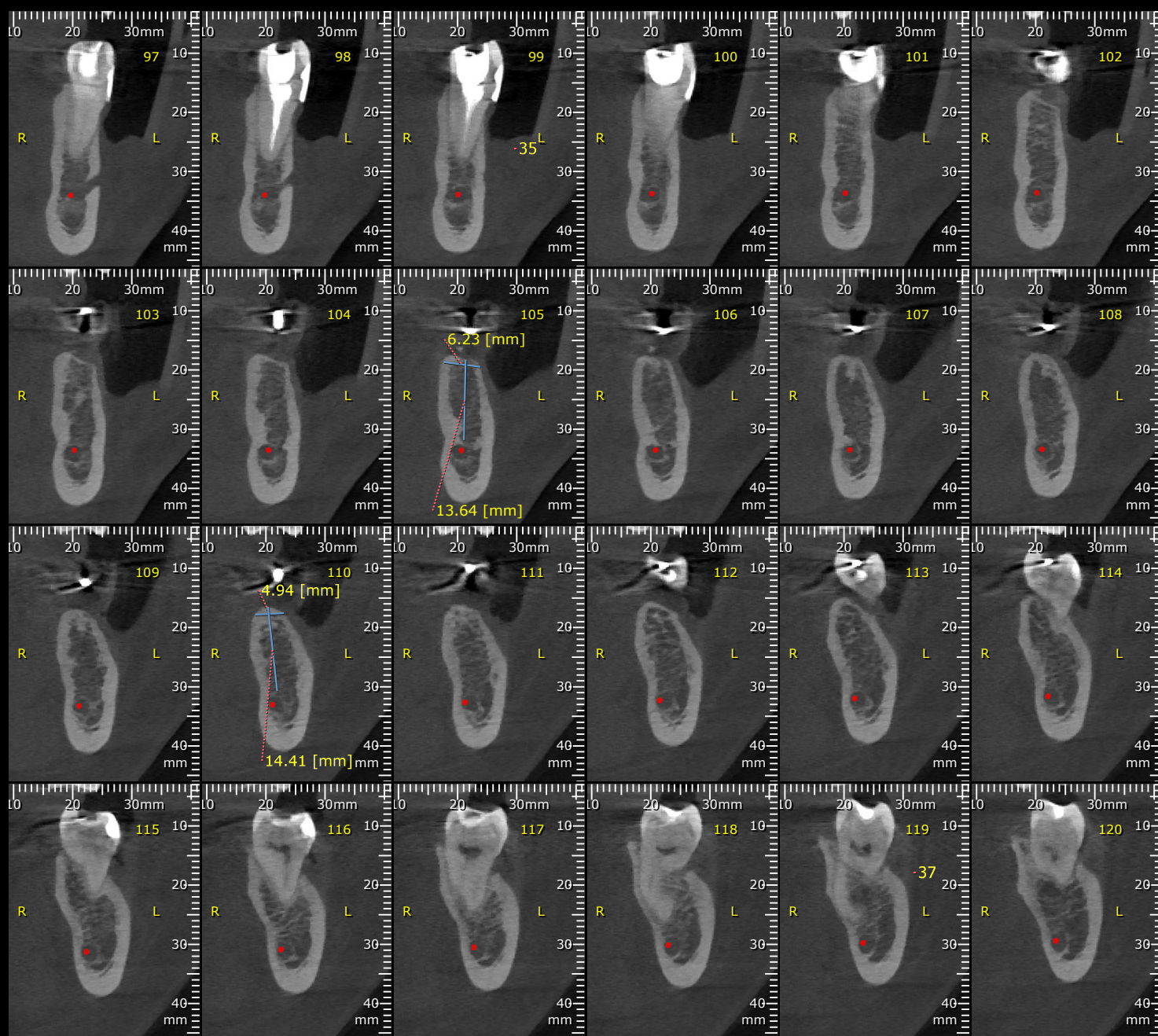
RECONSTRUÇÃO AXIAL



RECONSTRUÇÃO PANORÂMICA



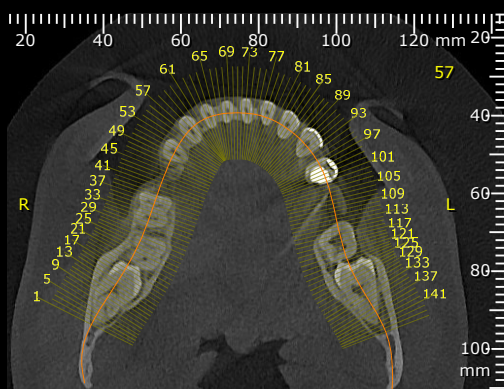
CORTES OBLÍQUOS (1:1), ESPESSAMENTO E ESPAÇAMENTO DE 1MM - TAMANHO REAL



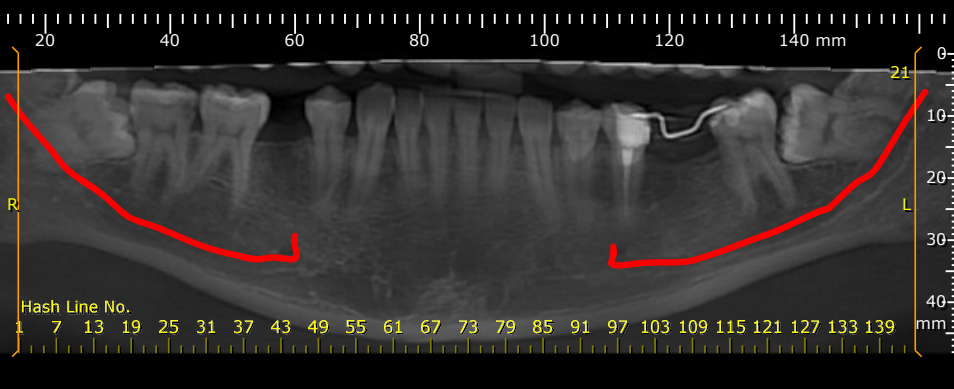
Legendas: SM: Seio Maxilar | CN: Cavidade Nasal | CS: Canalis Sinuosus | CNP: Canal Nasopalatino | CM: Canal da Mandíbula | FM: Forame Mental

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

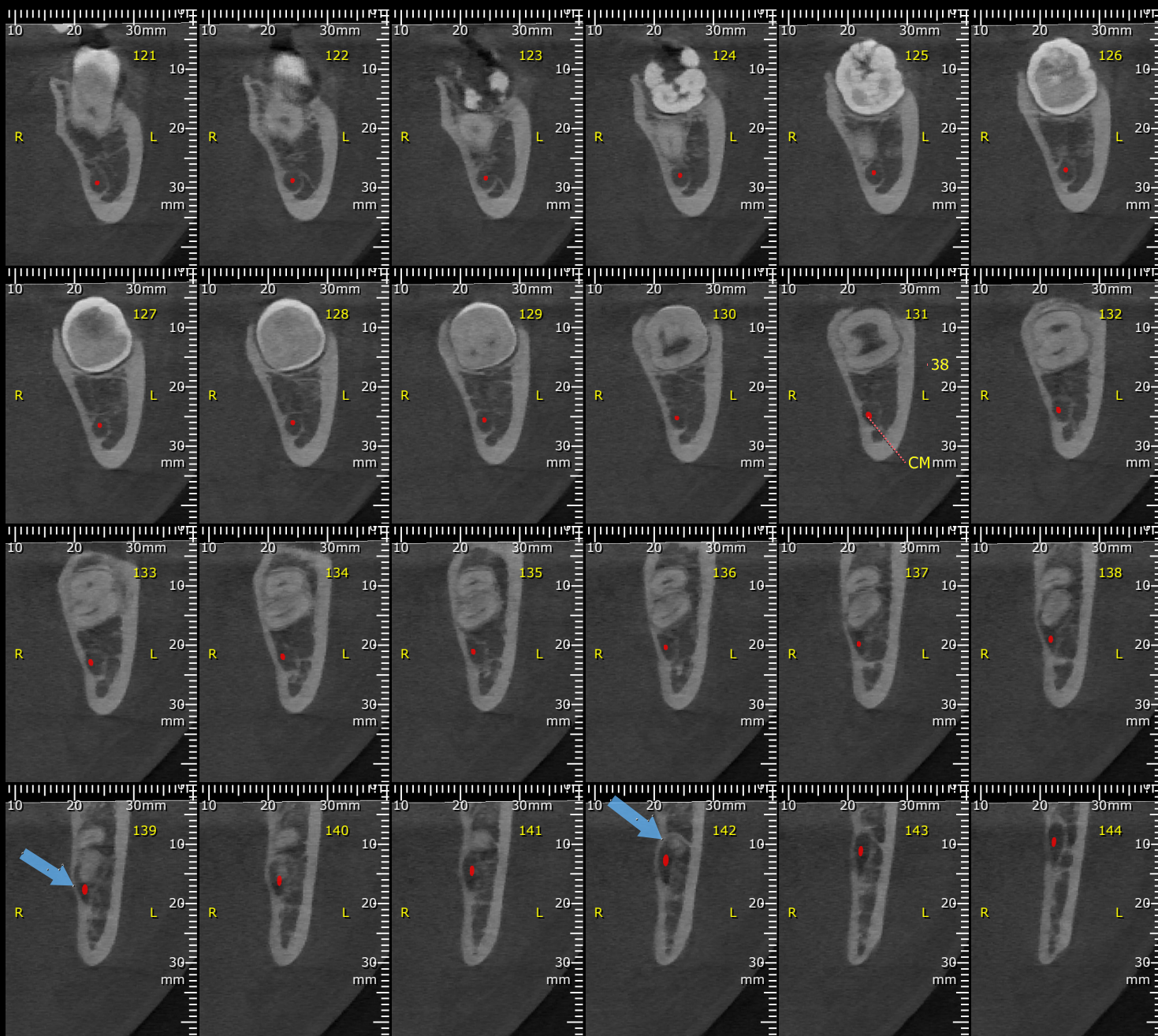
RECONSTRUÇÃO AXIAL



RECONSTRUÇÃO PANORÂMICA



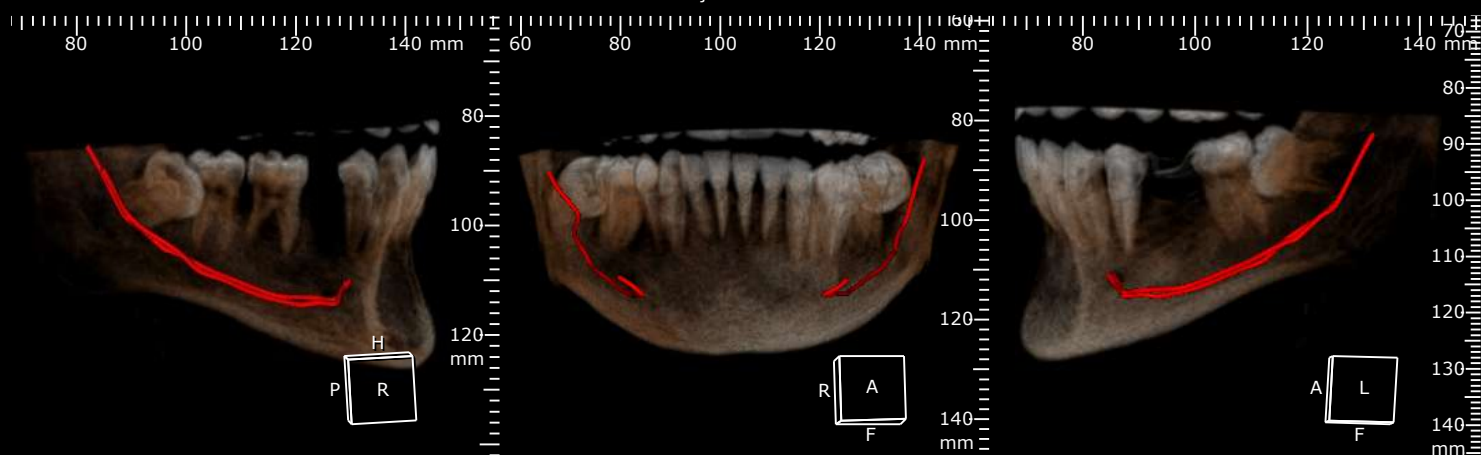
CORTES OBLÍQUOS (1:1), ESPESSAMENTO E ESPAÇAMENTO DE 1MM - TAMANHO REAL



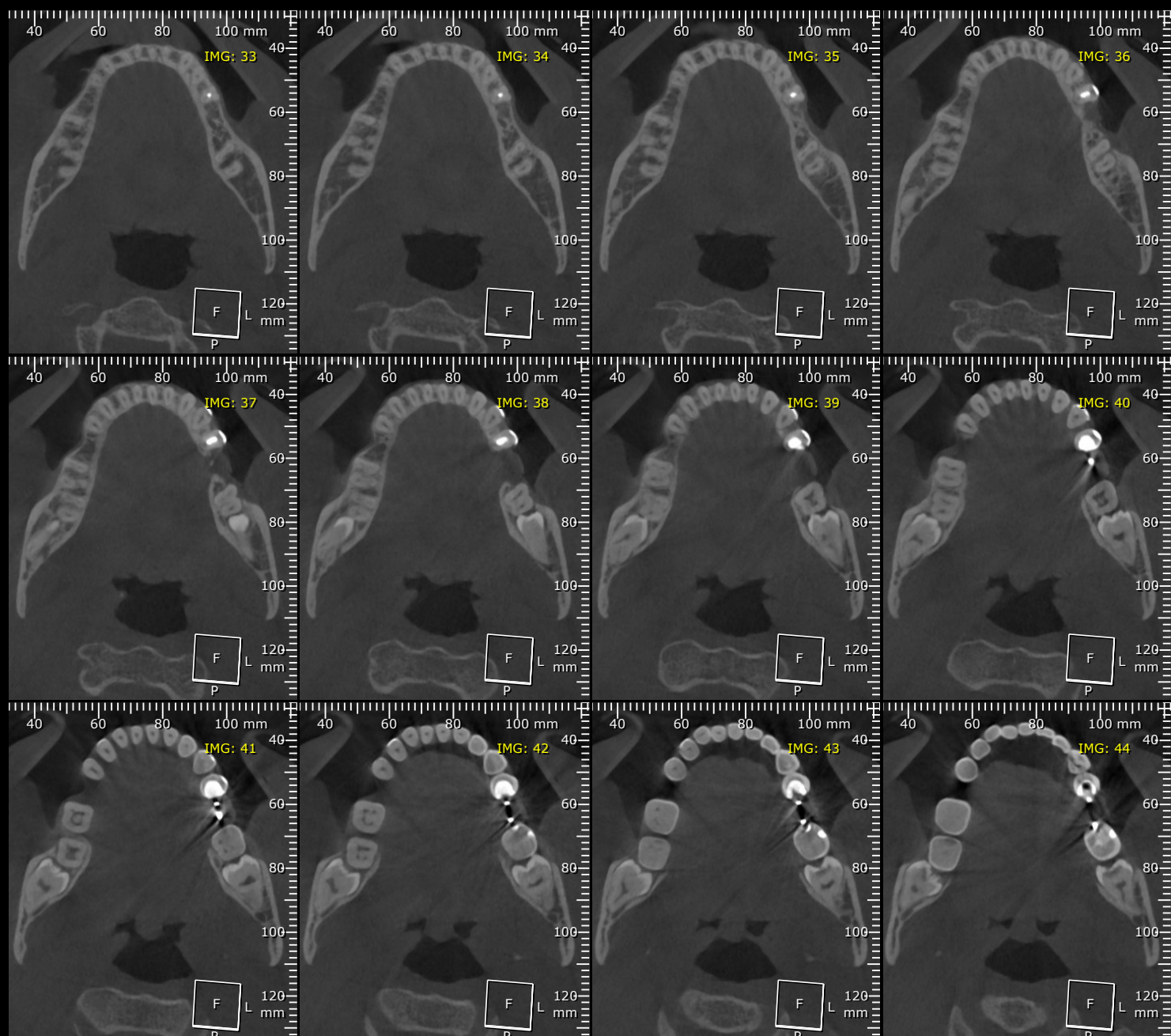
Legendas: SM: Seio Maxilar | CN: Cavidade Nasal | CS: Canalis Sinuosus | CNP: Canal Nasopalatino | CM: Canal da Mandíbula | FM: Forame Mental

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

RECONSTRUÇÕES 3D ILUSTRATIVAS

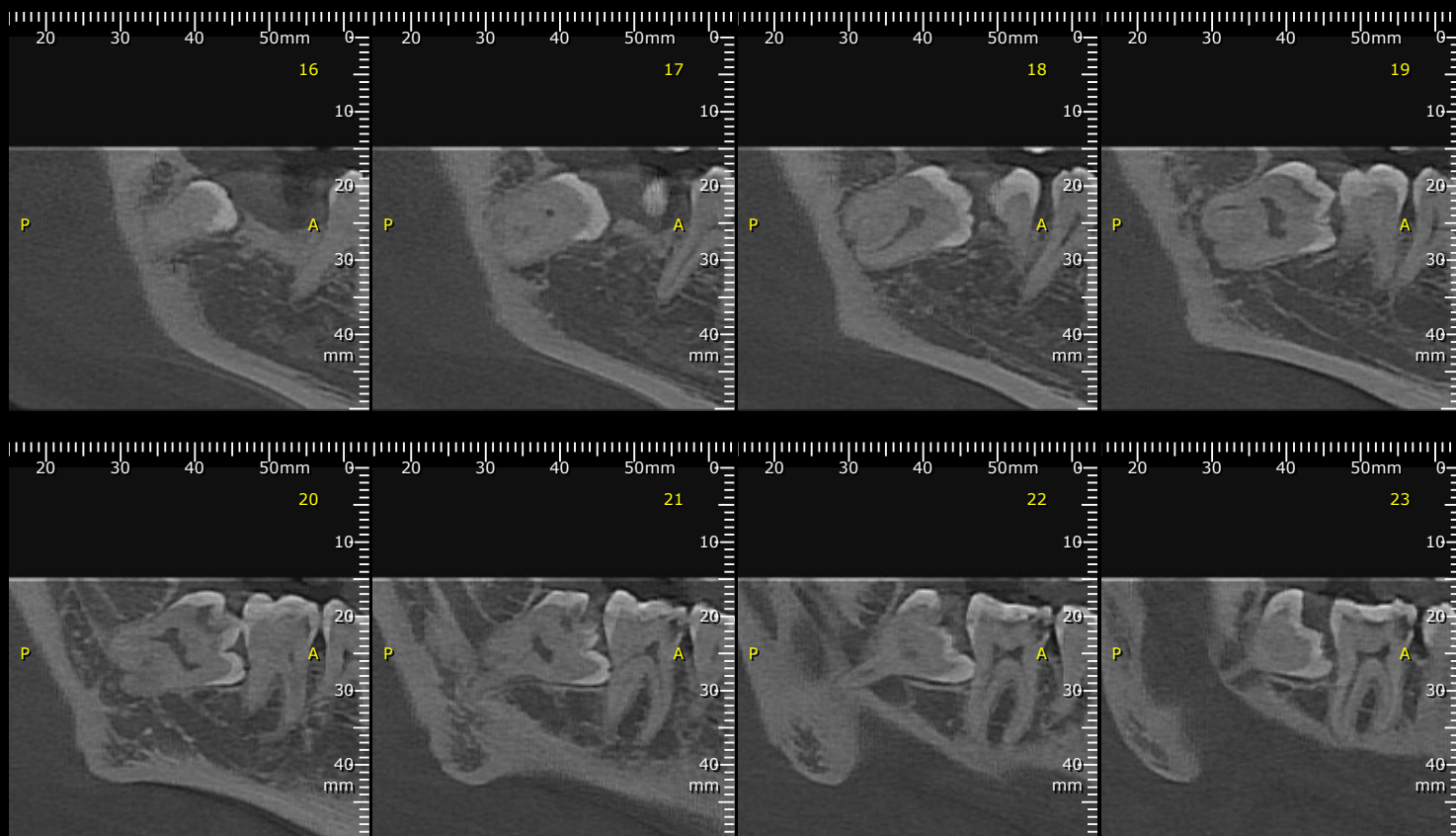


RECONSTRUÇÕES AXIAIS

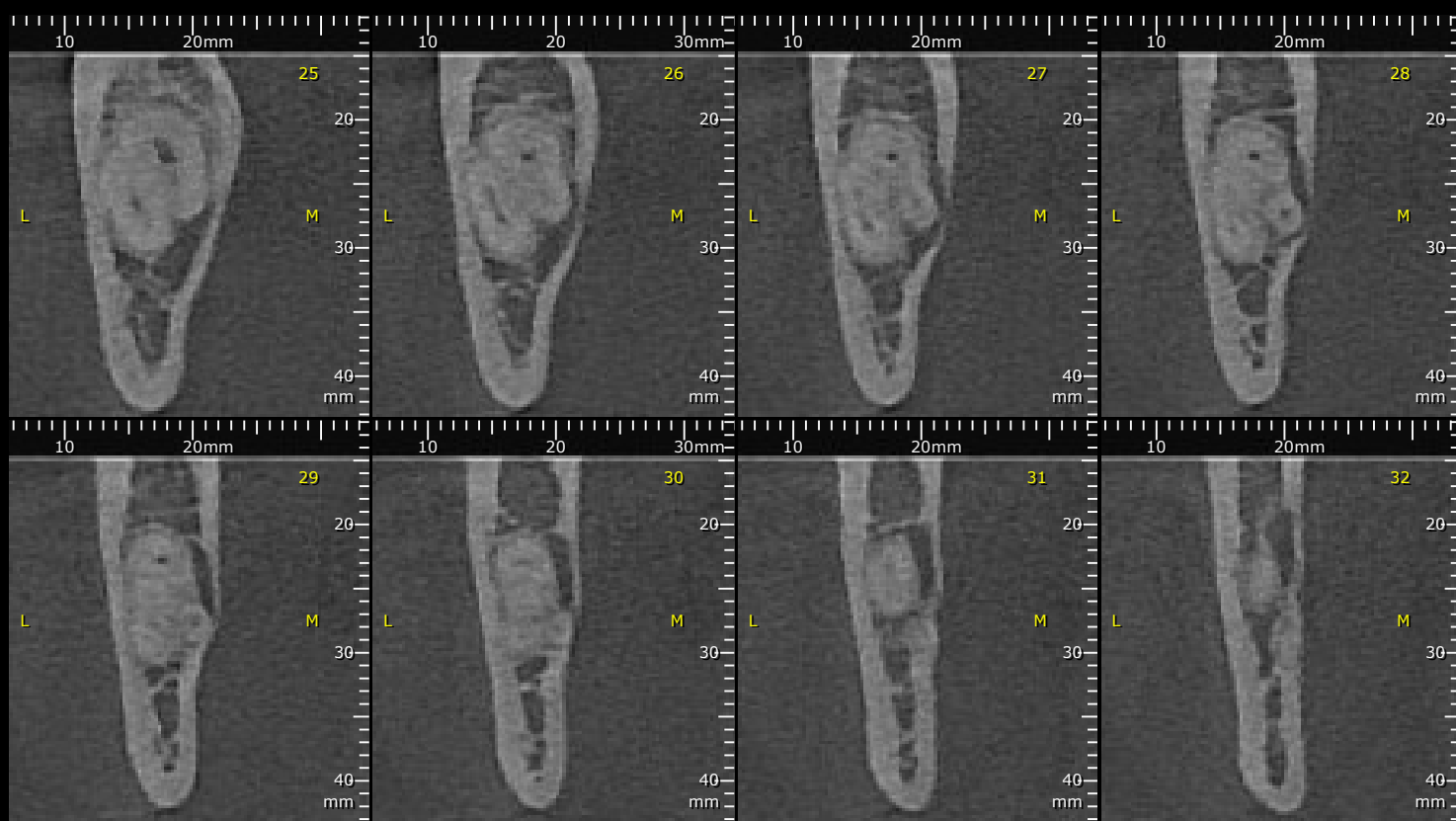


TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

RECONSTRUÇÕES SAGITAIS

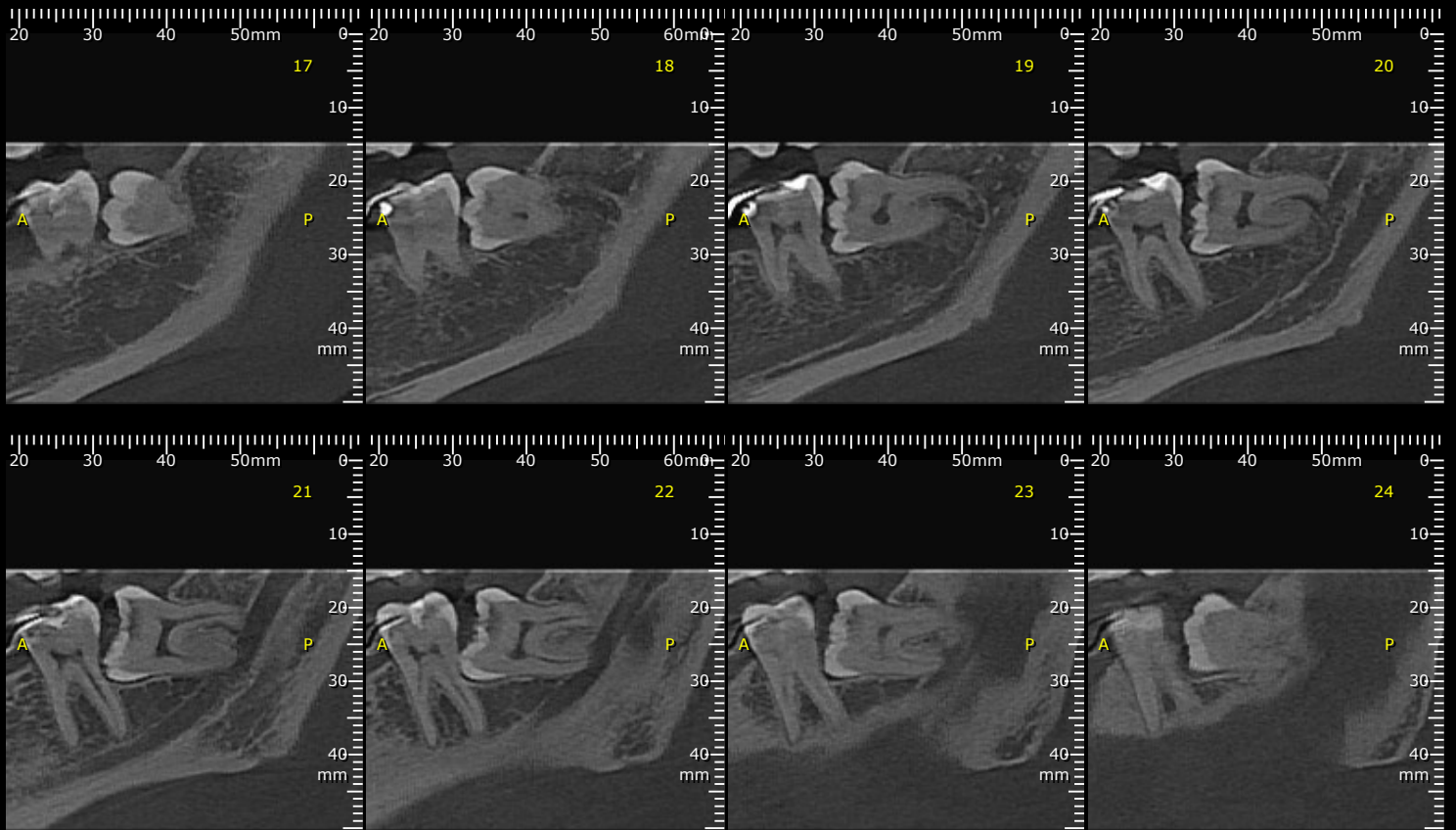


RECONSTRUÇÕES CORONAIS

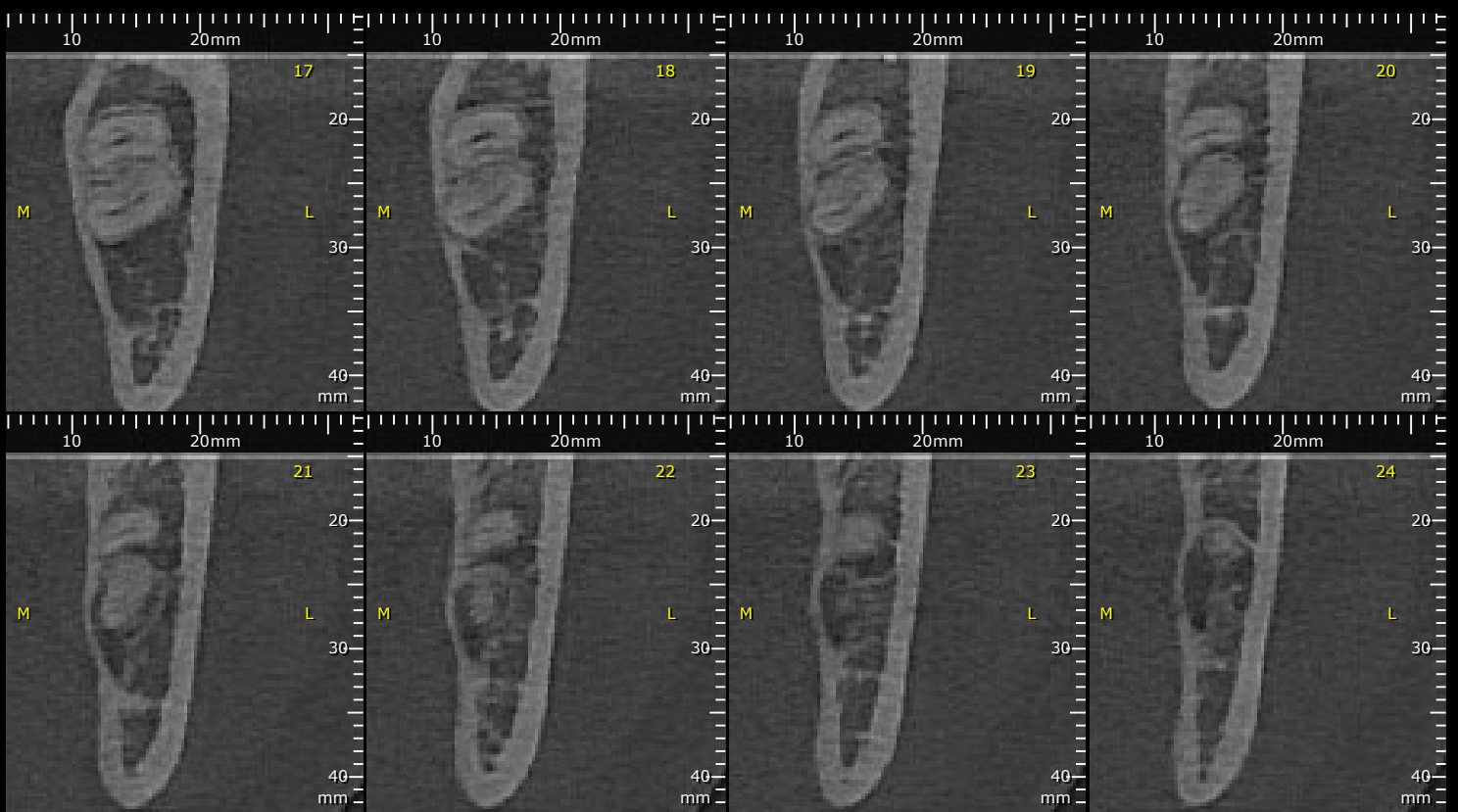


TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

RECONSTRUÇÕES SAGITAIS



RECONSTRUÇÕES CORONAIS



TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM DO COMPLEXO DENTO-MAXILO-FACIAL

PROTOCOLO

Foram realizadas reconstruções multiplanares, mostrando:

- Cortes transversais de 0,08mm de espessura com 1mm de afastamento entre eles. Estes cortes estão na escala 1:1 (tamanho real) e numerados no seu quadrante superior. A imagem coronal panorâmica e/ou axial localiza, onde foram realizados os cortes transversais, estão relacionados com os números indicados entre a imagem de localização e o corte. Para o estudo observou-se a totalidade do volume adquirido, sendo que as imagens geradas encontram-se documentadas em templates específicos que por sua vez representam um resumo de imagens reformatadas selecionadas. O exame tomográfico é um exame auxiliar, suas observações são consideradas sugestivas, portanto necessitam de confirmação clínica.
- As imagens de reconstrução 3D, sendo apenas de caráter ilustrativo.

ÁREA DE ESTUDO: 38 e 48

ANÁLISES GERAIS

- Dente(s) ausente(s): 45 e 36;
- Presença de material restaurador odontológico hiperdenso no(s) dente(s): 37 (OV), 35 (OV), 34 (V), 43 (V), 46 (O) e 47 (O); associar com dados clínicos;
- Presença de artefato metálico fixado na vestibular dos dentes 35 e 36;
- Presença de material obturador hiperdenso aquém do limite apical do conduto radicular do dente 35;
- Para melhor avaliação e diagnóstico de lesões de cárie dentária recomenda-se radiografias interproximais;
- Dente 38 e 48 semi irrompido / impactado em posição mesioinclinado - A coroa do dente 38 está em contato com a raiz distal do dente 37. o mesmo ocorre com a coroa do 48 que está em contato com a raiz distal do 47;
- Observa-se relação de contato da cortical óssea lateral e superior do canal mandibular direito com a porção apical e terço médio da raiz do dente 48;
- Observa-se relação de contato da cortical óssea superior do canal mandibular esquerdo com o terço apical da raiz do dente 38;
- Canal mandibular apresenta-se com aspecto de normalidade;
- Em algumas regiões foram realizadas mensurações ósseas, para medidas de outras regiões ou em outras inclinações basta utilizar uma régua milimetrada, já que os cortes apresentam tamanhos reais.
- Ressaltamos que o exame de tomografia computadorizada de feixe cônico, assim como qualquer exame por imagem, é um exame complementar, sendo as informações clínicas de fundamental importância para a conclusão do diagnóstico;
- Para melhor observação dos achados tomográficos descritos acima, sugere-se navegação tridimensional no arquivo DICOM, que segue em anexo ao exame.

CONCLUSÃO

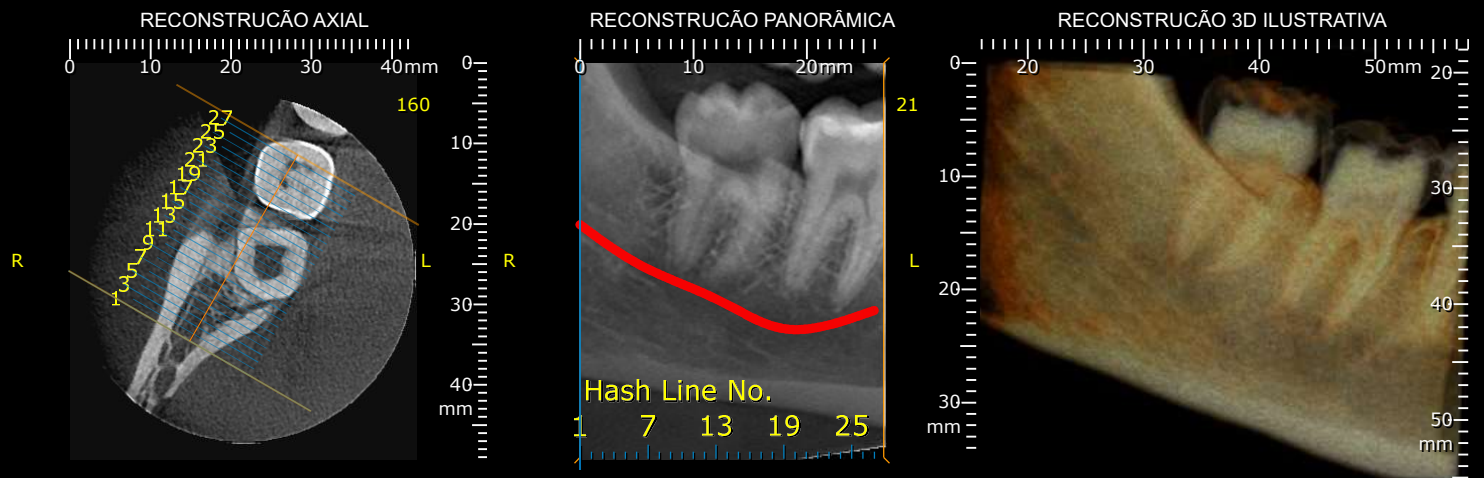
- *As medidas nos cortes transversais são somente uma sugestão, compete exclusivamente ao Implantodontista/Cirurgião-Dentista determinar a necessidade, posição, inclinações e diâmetros dos implantes, de acordo com o planejamento cirúrgico/protético.*
- *Recomenda-se avaliação clínica dos resultados obtidos no exame tomográfico para melhor elucidação do diagnóstico.*
- *Ressaltamos que os artefatos de imagem gerados pela estrutura metálica, coroas protéticas, retentor radicular, bráquetes e material obturador intracanal podem levar a um resultado falso negativo ou positivo para trinca radicular e lesões cariosas. Sugere-se criteriosa correlação dos cortes tomográficos e radiografias periapicais com os dados clínicos, comparar com imagens anteriores e exames complementares.*

Atenciosamente

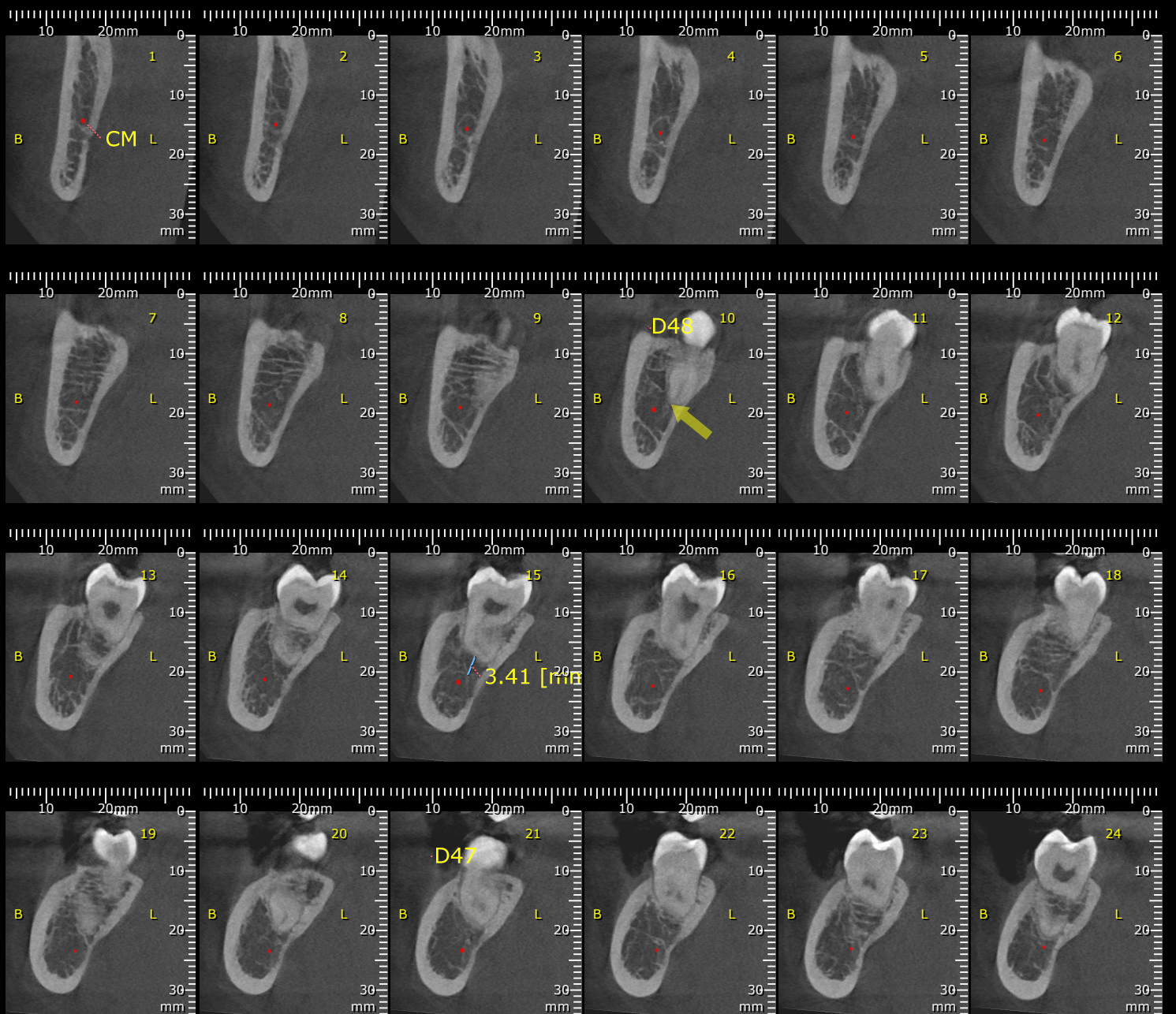


Ms. Sávio Bisinoto de Leles
Mestre e Esp. em Ortodontia
Esp. em Radiologia e Imaginologia Odontológica
CROGO - 15026

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM



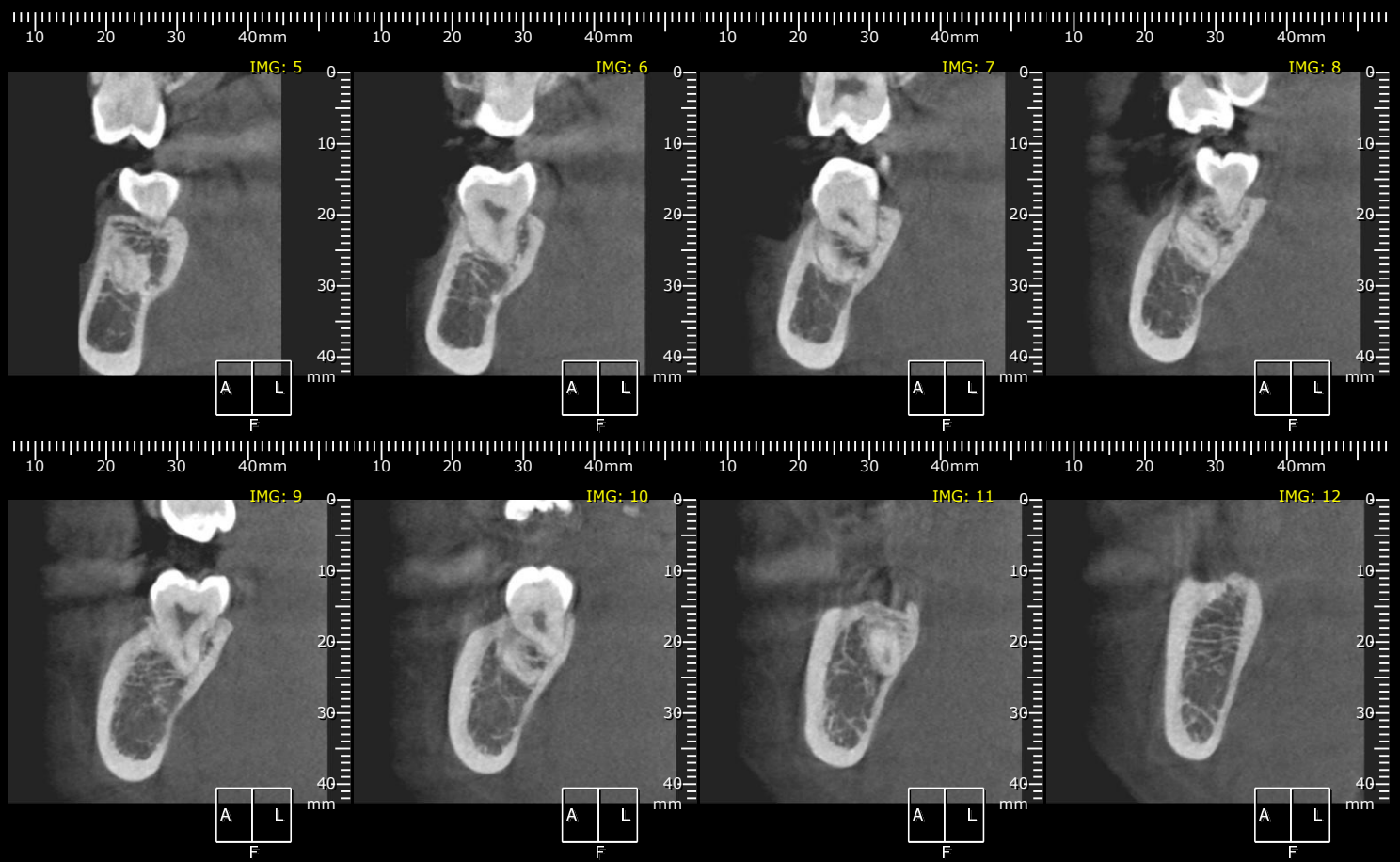
CORTES OBLIQUOS (1:1), ESPESSAMENTO E ESPACAMENTO DE 1MM - TAMANHO REAL



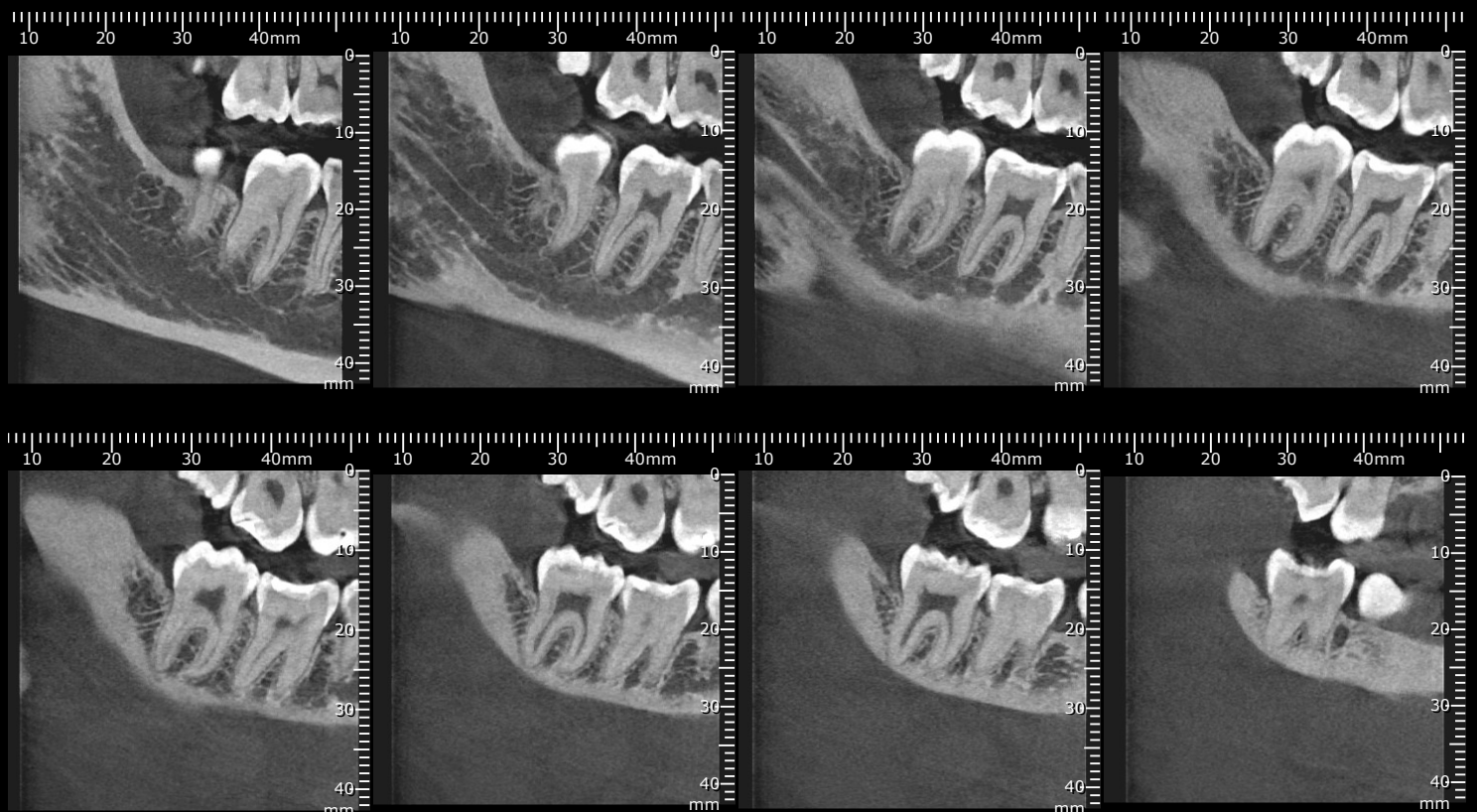
Legendas: SM: Seio Maxilar | CN: Cavidade Nasal | CS: Canalis Sinuosus | CNP: Canal Nasopalatino | CM: Canal da Mandíbula | FM: Forame Mental

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

RECONSTRUÇÕES CORONAIS - DENTE 48

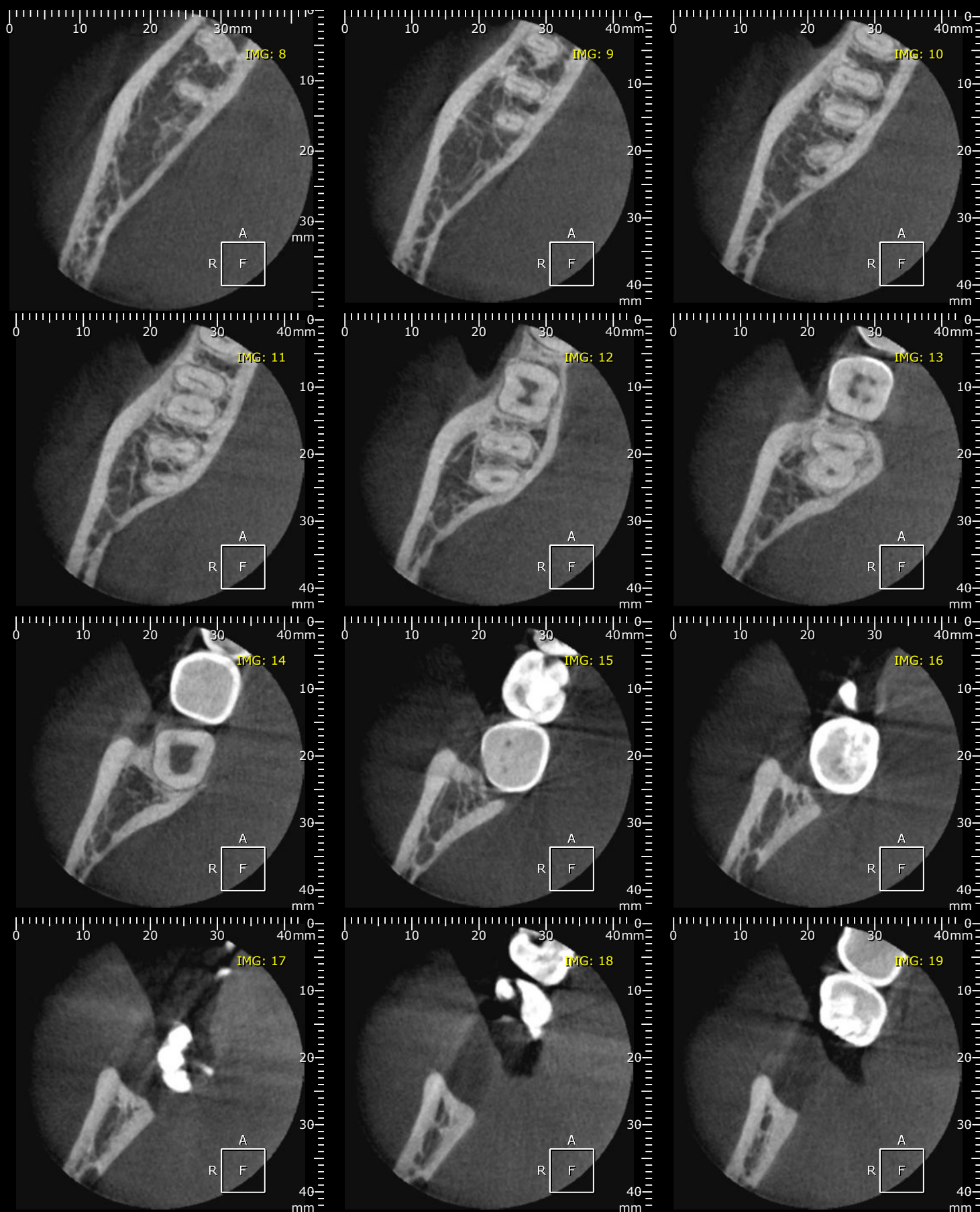


RECONSTRUÇÕES SAGITAIS EXTRAS - DENTE 48



TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

RECONSTRUÇÕES AXIAIS - DENTE 48



TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM DO COMPLEXO DENTO-MAXILO-FACIAL

PROTOCOLO

Foram realizadas reconstruções multiplanares, mostrando:

- Cortes transversais de 0,08mm de espessura com 1mm de afastamento entre eles. Estes cortes estão na escala 1:1 (tamanho real) e numerados no seu quadrante superior. A imagem coronal panorâmica e/ou axial localiza, onde foram realizados os cortes transversais, estão relacionados com os números indicados entre a imagem de localização e o corte. Para o estudo observou-se a totalidade do volume adquirido, sendo que as imagens geradas encontram-se documentadas em templates específicos que por sua vez representam um resumo de imagens reformatadas selecionadas. O exame tomográfico é um exame auxiliar, suas observações são consideradas sugestivas, portanto necessitam de confirmação clínica.
- As imagens de reconstrução 3D, sendo apenas de caráter ilustrativo.

ÁREA DE ESTUDO: 48

ANÁLISES GERAIS

- Dentes permanentes presentes na incidência solicitada: 48, 47;
- Dente(s) irrompido(s) classe 1 segundo Pell e Gregory e em posição do tipo A em relação ao plano oclusal do segundo molar;
- Nota-se proximidade da cortical superior do canal da mandíbula com o ápice da raiz distal do dente 48;
- Canal mandibular com aspecto de normalidade;
- Trabeculado ósseo mandibular apresenta-se com moderada densidade, envolto por osso cortical de moderada espessura;
- Em algumas regiões foram realizadas mensurações ósseas, para medidas de outras regiões ou em outras inclinações basta utilizar uma régua milimetrada, já que os cortes apresentam tamanhos reais.
- Ressaltamos que o exame de tomografia computadorizada de feixe cônico, assim como qualquer exame por imagem, é um exame complementar, sendo as informações clínicas de fundamental importância para a conclusão do diagnóstico;
- Para melhor observação dos achados tomográficos descritos acima, sugere-se navegação tridimensional no arquivo DICOM, que segue em anexo ao exame.

CONCLUSÃO

- *As medidas nos cortes transversais são somente uma sugestão, compete exclusivamente ao Implantodontista/Cirurgião-Dentista determinar a necessidade, posição, inclinações e diâmetros dos implantes, de acordo com o planejamento cirúrgico/protético.*
- *Recomenda-se avaliação clínica dos resultados obtidos no exame tomográfico para melhor elucidação do diagnóstico.*
- *Ressaltamos que os artefatos de imagem gerados pela estrutura metálica, coroas protéticas, retentor radicular, bráquetes e material obturador intracanal podem levar a um resultado falso negativo ou positivo para trinca radicular e lesões cariosas. Sugere-se criteriosa correlação dos cortes tomográficos e radiografias periapicais com os dados clínicos, comparar com imagens anteriores e exames complementares.*

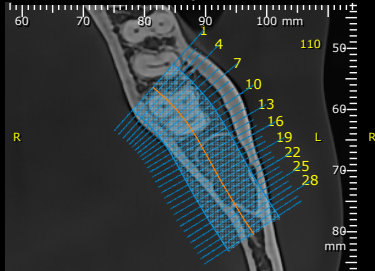
Atenciosamente



Ms. Sávio Bisinoto de Leles
Mestre e Esp. em Ortodontia
Esp. em Radiologia e Imaginologia Odontológica
CROGO - 15026

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

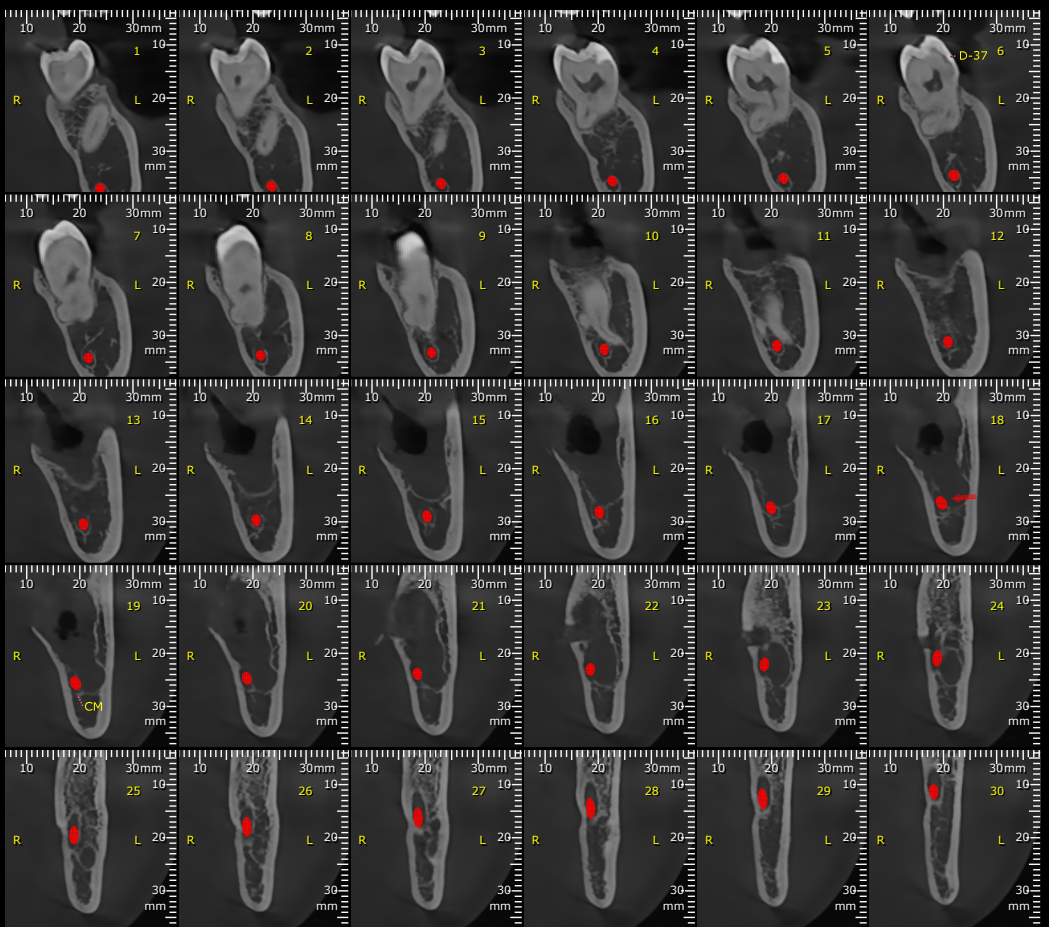
RECONSTRUÇÃO AXIAL



RECONSTRUÇÃO PANORÂMICA



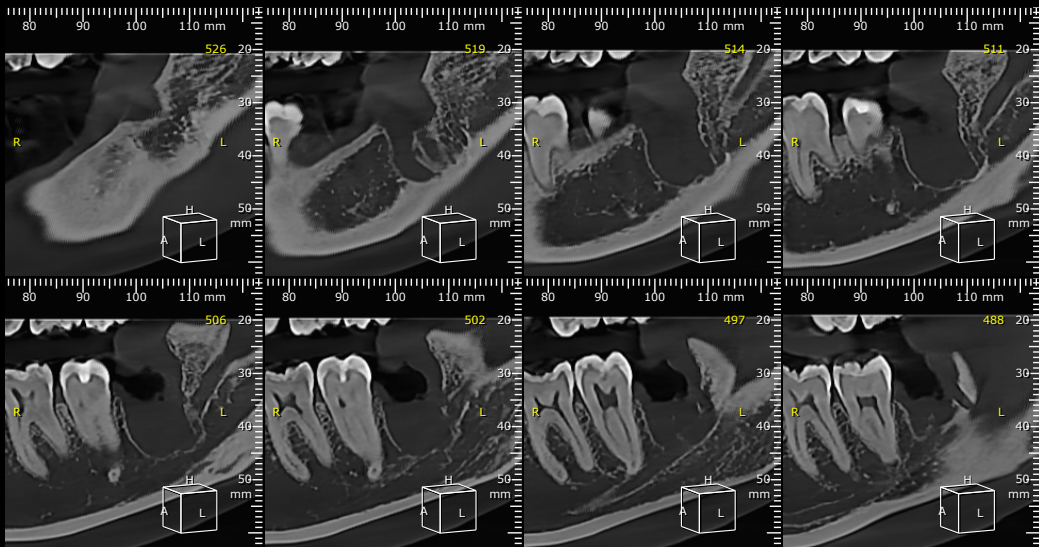
CORTES TRANSVERSAIS (1:1), ESPESSAMENTO E ESPAÇAMENTO DE 1MM - TAMANHO REAL



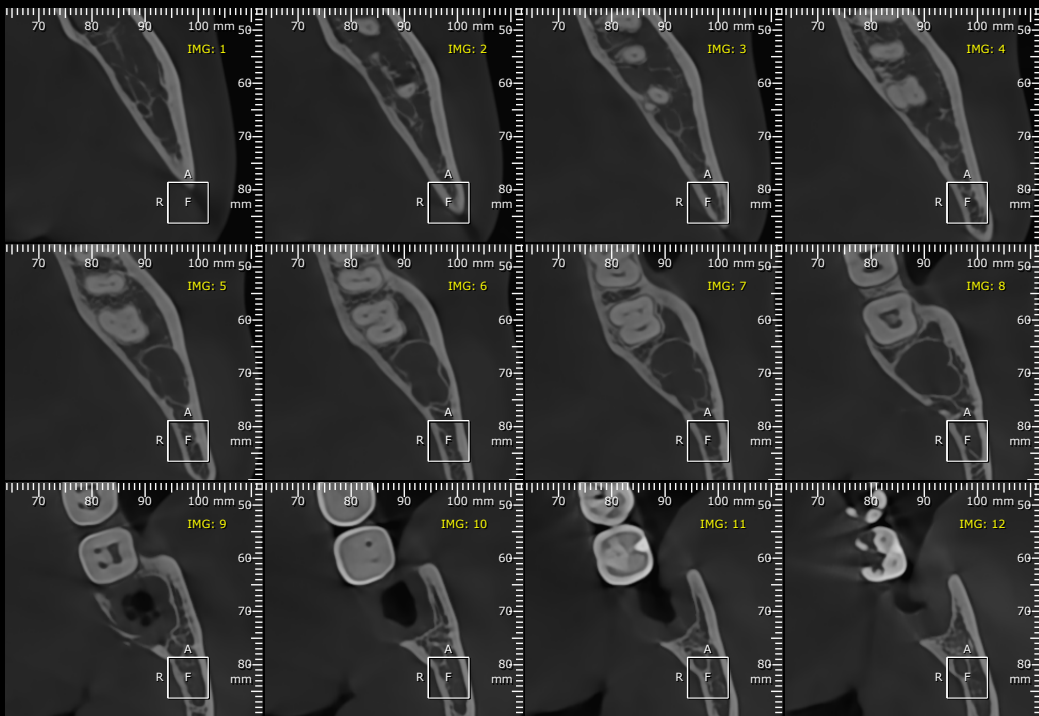
Legendas: SM: Seio Maxilar | CN: Cavidade Nasal | CS: Canalis Sinuosus | CNP: Canal Nasopalatino | CM: Canal da Mandíbula | FM: Forame Mental

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

RECONSTRUÇÕES LONGITUDINAIS

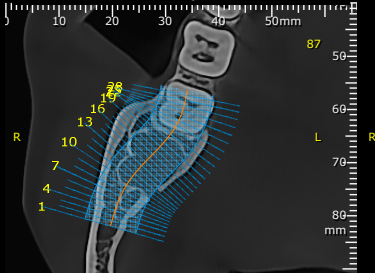


RECONSTRUÇÕES AXIAIS



TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

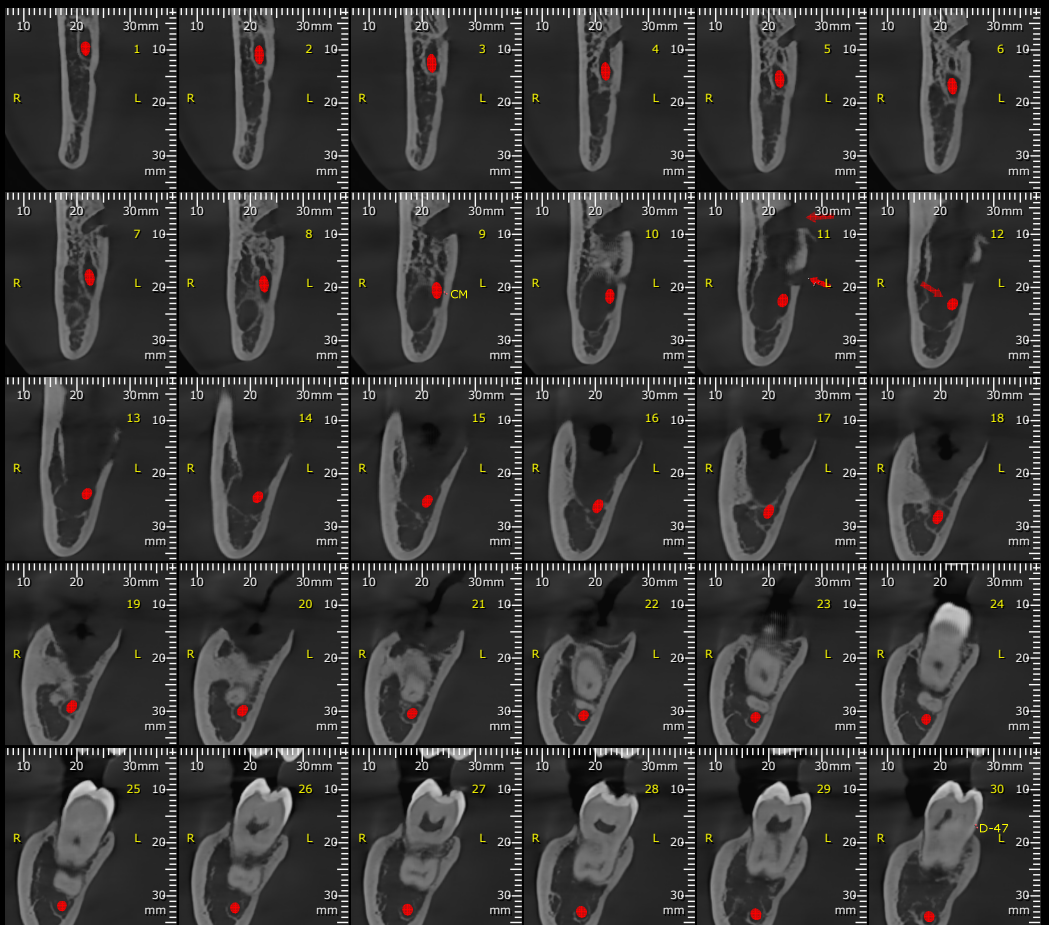
RECONSTRUÇÃO AXIAL



RECONSTRUÇÃO PANORÂMICA



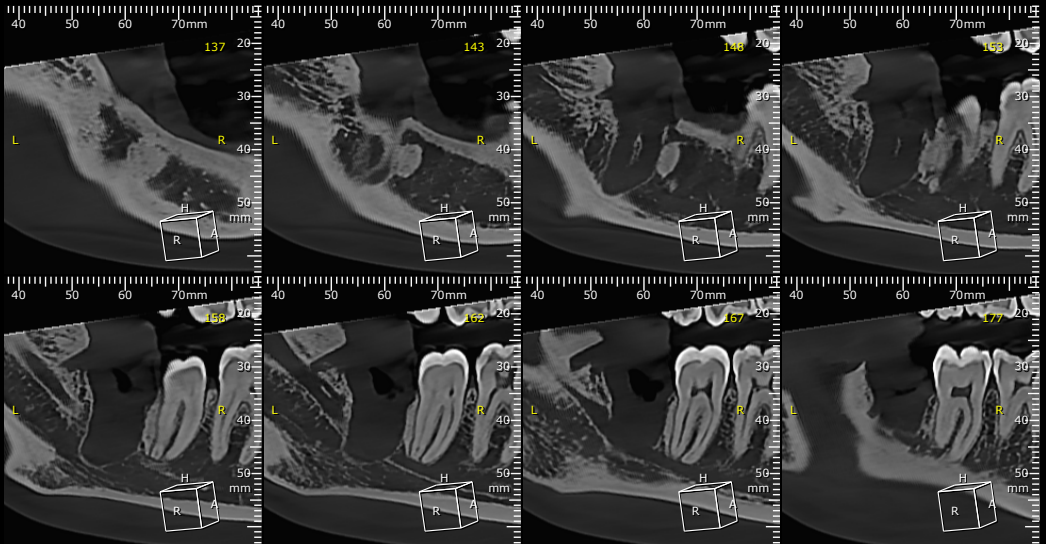
CORTES TRANSVERSAIS (1:1), ESPESSAMENTO E ESPAÇAMENTO DE 1MM - TAMANHO REAL



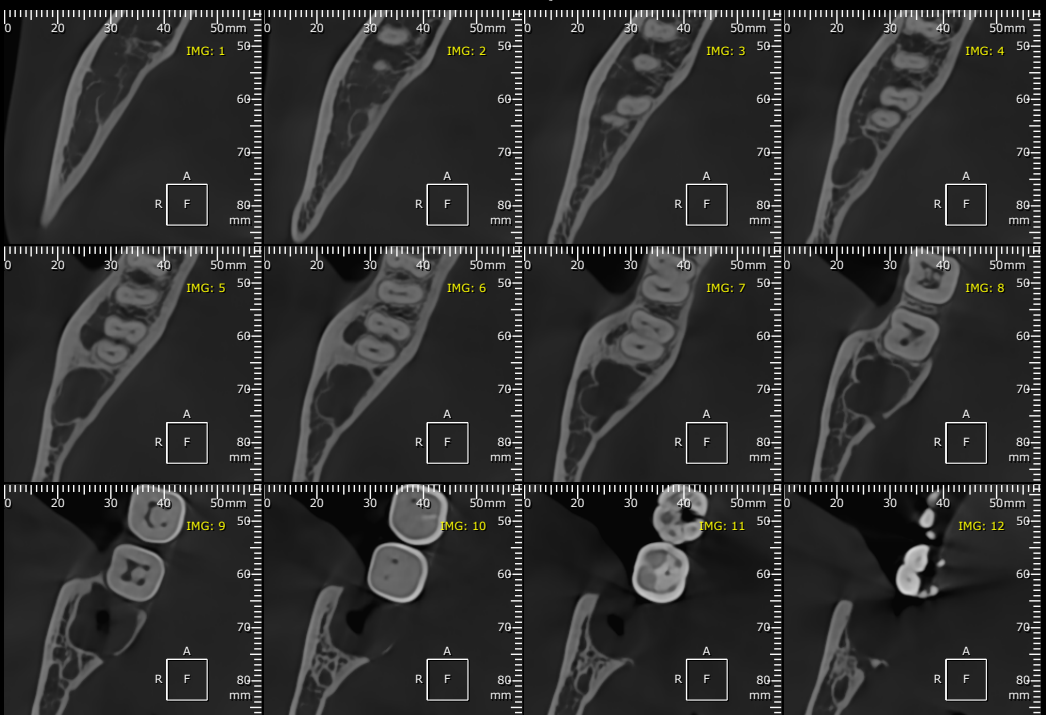
Legendas: SM: Seio Maxilar | CN: Cavidade Nasal | CS: Canalis Sinuosus | CNP: Canal Nasopalatino | CM: Canal da Mandíbula | FM: Forame Mental

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

RECONSTRUÇÕES LONGITUDINAIS



RECONSTRUÇÕES AXIAIS



TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM

RECONSTRUÇÕES TRIDIMENSIONAIS

0 20 40 60 80 100 120 140 160 mm



40
60
80
100
120
140
mm

0 20 40 60 80 100 120 140 160 mm



40
60
80
100
120
140
mm

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM DO COMPLEXO DENTO-MAXILO-FACIAL

PROTOCOLO

Foram realizadas reconstruções multiplanares, mostrando:

- Cortes transversais de 0,08mm de espessura com 1mm de afastamento entre eles. Estes cortes estão na escala 1:1 (tamanho real) e numerados no seu quadrante superior. A imagem coronal panorâmica e/ou axial localiza, onde foram realizados os cortes transversais, estão relacionados com os números indicados entre a imagem de localização e o corte. Para o estudo observou-se a totalidade do volume adquirido, sendo que as imagens geradas encontram-se documentadas em templates específicos que por sua vez representam um resumo de imagens reformatadas selecionadas. O exame tomográfico é um exame auxiliar, suas observações são consideradas sugestivas, portanto necessitam de confirmação clínica.
- As imagens de reconstrução 3D, sendo apenas de caráter ilustrativo.

ÁREA DE ESTUDO: 38 / 48

ANÁLISES GERAIS

- Dente(s) ausente(s): 38 e 48;
- Presença de material restaurador odontológico no(s) dente(s): 37(V);
- Área de hipodensidade na região alveolar do elemento 38, compatível com alvéolo dental em processo de reparação óssea pós-exodontia. Observa-se descontinuidade da cortical superior do canal mandibular, evidenciando comunicação direta entre o canal e a cavidade alveolar (corte transversal 17 - 18);
- Área de hipodensidade na região alveolar do elemento 48, compatível com alvéolo dental em processo de reparação óssea pós-exodontia. Observa-se descontinuidade da cortical superior do canal mandibular, evidenciando comunicação direta entre o canal e a cavidade alveolar (corte transversal 12 - 15);
- Ressaltamos que o exame de tomografia computadorizada de feixe cônico, assim como qualquer exame por imagem, é um exame complementar, sendo as informações clínicas de fundamental importância para a conclusão do diagnóstico;
- Para melhor observação dos achados tomográficos descritos acima, sugere-se navegação tridimensional no arquivo DICOM, que segue em anexo ao exame.

CONCLUSÃO

- *As medidas nos cortes transversais são somente uma sugestão, compete exclusivamente ao Implantodontista/Cirurgião-Dentista determinar a necessidade, posição, inclinações e diâmetros dos implantes, de acordo com o planejamento cirúrgico/protético.*
- *Recomenda-se avaliação clínica dos resultados obtidos no exame tomográfico para melhor elucidação do diagnóstico.*

- Ressaltamos que os artefatos de imagem gerados pela estrutura metálica, coroas protéticas, retentor radicular, bráquetes e material obturador intracanal podem levar a um resultado falso negativo ou positivo para trinca radicular e lesões cariosas. Sugere-se criteriosa correlação dos cortes tomográficos e radiografias periapicais com os dados clínicos, comparar com imagens anteriores e exames complementares.

Atenciosamente



Ms. Sávio Bisinoto de Leles
Mestre e Esp. em Ortodontia
Esp. em Radiologia e Imaginologia Odontológica
CROGO - 15026